

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°138/MVE-BDBV/29/09/2026

Date du rapport : 29 septembre 2026

Date de publication : 30 septembre 2026


FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Au cours de la journée du 29 septembre 2026, 53 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 22 décès communautaires ont été notifiés. Les cas confirmés rapportés étaient répartis dans les provinces de l'Ituri (32 cas), du Nord-Kivu (17 cas), du Haut-Uélé (4 cas). De plus, 6 décès ont été enregistrés dans les CTE.
- Un total de 328 nouveaux échantillons a été analysé ; 53 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 16,2 % de positivité.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS
8 224

CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS
3 982

LETALITE
48,4 %

PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE
851

CUMUL DES GUÉRIS
2 121

TAUX DE SUIVI DES CONTACTS
(Du Jour)
78,7 %


Provinces touchées et zones de santé touchées


7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



63 Zones de santé touchées sur 167 (37,7%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Cinquante-trois (53) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **22 décès communautaires** ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les provinces ayant rapporté ces cas sont l'Ituri (32 cas), du Nord-Kivu (17 cas) et (4 cas) du Haut-Uélé.

Par ailleurs, **6 décès ont été enregistrés dans les CTE** (4 en Ituri, 1 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé), ce qui porte à 28 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Cependant, 16 patients (**12 en Ituri, 3 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé**) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Au 29 septembre 2026, la RDC cumule **8 224 cas confirmés et 3 982 décès** (létalité : **48,4 %**). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **76,0 %** des cas confirmés cumulés rapportés et **60,4 %** des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit **59,3%**.

Au total, **63 zones de santé sur 167 (37,7 %)**, réparties dans **sept provinces**, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 29 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	32	6250	2 885	46,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	17	1570	931	59,3%	16/34 (47,1 %)
Haut-Uélé	4	344	144	41,9%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	0	45	16	35,6%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	53	8 224	3 982	48,4%	63/167 (37,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 29 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6250	2885	46,2%	32	13	4	17
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	202	46	22,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1728	561	32,5%	14	7		7
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	82	31	37,8%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	35	12	34,3%				0
Komanda	169	102	60,4%	1		1	1
Lita	284	143	50,4%				0
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	34	9	26,5%	1		1	1
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	29	11	37,9%				0
Mandima	137	75	54,7%	6	4		4
Mangala	351	154	43,9%	1	1		1
Mongbwalu	701	331	47,2%	1		1	1
Nia-Nia	298	162	54,4%	3	1		1
Nizi	778	279	35,9%	3			0
Nyankunde	129	37	28,7%	1			0
Rimba	12	4	33,3%				0
Rwampara	1083	369	34,1%	1		1	1

Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler *	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1570	931	59,3%	17	8	1	9
Beni	348	229	65,8%	5	1	0	1
Biena	19	7	36,8%	1			0
Butembo	263	170	64,6%	5	3	0	3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	54	18	33,3%				0
Katwa	562	357	63,5%	3	2	0	2
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	33	20	60,6%				0
Lubero	21	11	52,4%				0
Mabalako	33	12	36,4%	1	1	0	1
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	29	9	31,0%	1	0	0	0
Musienene	124	67	54,0%	1	1	0	1
Mutwanga	12	2	16,7%				0
Oicha	26	14	53,8%				0
Vuhovi	31	10	32,3%	0	0	1	1
Haut-Uélé	344	144	41,9%	4	1	1	2
Boma Mangbetu	39	17	43,6%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	85	39	45,9%	2	0	1	1
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	112	41	36,6%	2	1	0	1
Tshopo	45	16	35,6%	0	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	24	10	41,7%				0
Mangobo	6	3	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8224	3982	48,4%	53	22	6	28

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 29 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas Uélé	118	2	120	12	1	107	0	13	0
Ituri	1 132	67	1199	143	67	989	0	210	129
Nord-Kivu	459	0	459	112	0	347	0	112	88
Sud Ubangi	42	0	42	0	0	42	0	0	0
Tshopo	149	2	151	10	2	139	0	12	1
Total Général	1 900	71	1 971	277	70	1 624	0	347	218

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

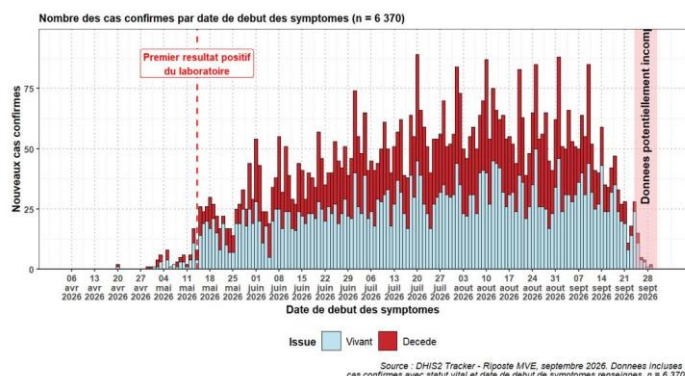
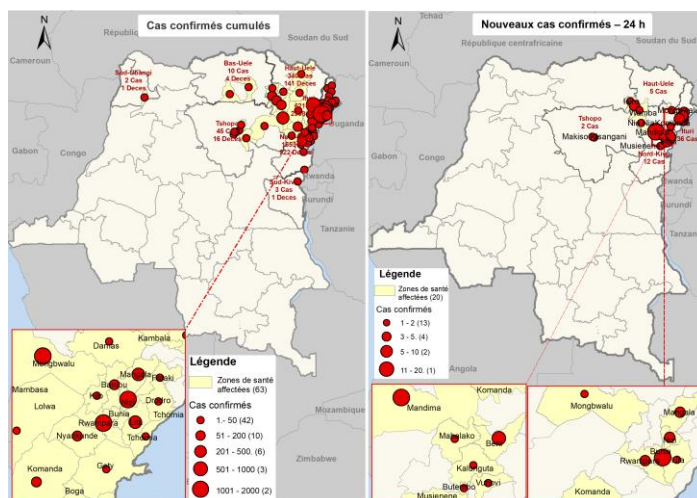


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au décours de la journée du 29 septembre 2026, **1 971** alertes ont été remontées, **1 971** (100,0 %) ont été vérifiées. Les **334** (16,9 %) alertes validées comme cas suspects ont tous été investiguées. Ainsi, 218 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi **30 751** contacts en cours de suivi, **24 206** contacts ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **78,7 %**, inférieure à celle de la veille (82,0 %) et au seuil requis (95,0 %). Cette proportion était de 93,9 % (92/98) au Sud Ubangi, 85,3 % (12 248/14 363) en Ituri, 87,0 % (161/185) au Bas Uélé et 83,7 % (638/762) à la Tshopo, 71,4 au Nord-Kivu (10 260/14 367) et 82,7 % au Haut-Uélé (807/976).

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Cinq (5) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée, dont une (1) en Ituri, deux (2) au Nord-Kivu et deux (2) à la Tshopo (PoC PK 15, axe Buta). En Ituri, l'alerte du PoC Mabakese (ZS de Mambasa), un voyageur en provenance de Musienene, a été validée puis le suspect a été transféré au CTE de Mambasa (taux de transfert de 100 %) ; au Nord-Kivu, les deux alertes du PoC Karuruma ont été invalidées après investigation.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 29 septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	97,0% (96/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	138 080	94 428	19 533	252 041
% des voyageurs screenés	96,6%	98,2%	97,9%	97,3%
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,3%	98,2%	98,1%	97,2%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	98,2%	100,0%	99,1%
Nombre d'alertes notifiées	1	2	2	5
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	0	0	1
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	100,0%	NA	NA	100,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 32 nouveaux résultats positifs** (19 vivants et 13 décès) sur 175 échantillons reçus et analysés (**positivité : 18,3 %**).
- **Nord-Kivu : 17 nouveaux résultats positifs** (9 vivants et 8 décès) sur 124 échantillons reçus et analysés (**positivité : 13,7 %**).
- **Haut-Uélé : 4 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 1 décès) sur 21 échantillons reçus et analysés (**positivité : 19,0 %**).
- **Tshopo : 6 échantillons reçus et analysés** (6 vivants), tous sont revenus négatifs.
- **Bas Uélé : 2 échantillons reçus et analysés** (2 vivants), tous sont revenus négatifs.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 19 rings ont été ouverts sur 34 (55,9 %), 26 ménages décontaminés sur 37 (70,3 %) et 14 FOSA décontaminées sur 17 (82,4 %). Sur 82 alertes EDS (dont 5 reports), 60 EDS ont été réalisés (73,2 %) et 55 corps swabés.
- **Nord-Kivu** 12 rings ont été ouverts sur 19 (63,2 %), 3 ménages décontaminés sur 21 (14,3 %) et 15 ESS décontaminées sur 17 (88,2 %). Au total, 209 FOSA ont été suivies, 516 prestataires briefés et 61 EDS réalisés, avec 45 corps swabés sur 47 alertes reçues.
- **Haut-Uélé** : 3 rings ont été ouverts sur 3 (100 %), 21 ménages décontaminés sur 24 (87,5 %) et 7 ESS décontaminées sur 9 (77,8 %). Sur 5 alertes EDS, 3 EDS ont été réalisés et 3 corps swabés ; 2 échecs ont été enregistrés à Boma Mangbetu en raison de la résistance communautaire

- **Tshopo** : 18 ESS ont été suivies dans 6 ZS et 186 prestataires briefés ; la formation intégrée de 150 PPL des ESS privés a démarré à Makiso-Kisangani et le ménage des cas 38 et 39 ainsi que la clinique Kawaki (cas 44) ont été décontaminés. En cumul, 34 ESS sur 34 (100 %) et 26 ménages sur 31 (83,9 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures.
- **Bas-Uélé** : 10 ESS sur 10 ont été suivies à Viadana, Buta et Ganga et 34 prestataires briefés (100 %) ; la formation PCI/WASH de 35 PPL et de 35 hygiénistes se poursuit à Ganga (FHI 360). Sur 2 alertes EDS, 1 corps a été swabé et un échec a été enregistré à Koteli.

2.4.2. Défis

En Ituri, l'ouverture des rings demeure insuffisante (55,9 % ; 19/34), 15 corps n'ont pas été swabés faute d'intrants et d'équipes à Mandima ou à la suite de refus des familles, et aucun ménage ni aucune ESS n'a été doté en kits. **Au Nord-Kivu**, la décontamination des ménages reste très faible (14,3 % ; 3/21), aucun ménage décontaminé n'a été doté en kit (0/3), le score PCI moyen des 7 ESS évaluées est de 36,6 % et la promptitude/complétude des rapports PCI est de 56,3 % (9/16 ZS).

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 83 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 72 sorties, dont 12 guérisons. Au total, 392 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, Le taux d'occupation des lits était de **38,6 %** ; 94,1 % des patients ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (15/15), à la crèche (5/5) et dans la communauté (47/47) ; 35 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 68 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 68 sorties (3 guéries). Au total, 365 patients demeuraient hospitalisés dont 223 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **63,0 %**.
- **À la Tshopo**, 1 nouvelle admission a été enregistrée. Aucune sortie n'a été rapportée. Treize patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de **41,9%**.
- **Au Bas-Uélé**, 4 nouvelles admissions ont été enregistrées. Aucune sortie n'a été rapportée. Onze patients demeuraient en isolement à la fin de la journée.
- **Au Haut-Uélé**, 7 nouvelles admissions (1 confirmé et 6 suspects) ont été enregistrées contre 13 sorties, dont 1 guérison, 11 non-cas et 1 décès confirmé au CTE de Pawa. Au total, 70 patients (32 confirmés et 38 suspects) demeuraient en isolement dans les CTE, soit un taux d'occupation de **50,7 %** ; 74 patients, 148 accompagnants et 45 PPL ont bénéficié de repas chauds.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, faible capacité d'accueil de certains CTE/CT et l'insuffisance de la prise en charge alimentaire demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, la présence continue de cas confirmés en isolement nécessite le maintien des mesures de prévention et contrôle de l'infection.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 129 personnes ont été vaccinées le 29 septembre avec l'appui de MSF, dont 68 femmes et 61 hommes, sans MAPI notifiée. Le cumul atteint 731 personnes vaccinées, dont 319 femmes et 412 hommes. Les activités de vaccination et de recherche sur l'efficacité du vaccin ERVEBO contre la MVE-BDBV se poursuivent.
- **Au Bas-Uélé**, le cumul provincial atteint 1 022 PPL et TPL vaccinés sur une cible de 13 202 (7,7 %), principalement à Buta (572 ; 20,0 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %). Le déploiement des équipes de vaccination compassionnelle se prépare à Aketi et à Viadana.

2.6.2. Défis

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir, ce qui empêche le calcul d'un taux de couverture fiable.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC non effective, pas de disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, le pilier a évalué la continuité des services de vaccination dans 14 ZS affectées, avec un accent sur les unités itinérantes, afin de récupérer les enfants zéro dose et sous-vaccinés.
- **Au Haut-Uélé**, l'évaluation de l'hôpital secondaire de Nebobongo (ZS de Pawa) révèle une baisse d'environ 50 % de la fréquentation et de plus de 75 % des consultations prénatales, avec 55 % des services fonctionnels (rupture majeure) ; 2 PPL sont suivis au CTE de Wamba.
- **À la Tshopo**, le Centre médical Horizon a été évalué (2 agents vaccinés sur 11, soit 18,2 %, et zone de triage non effective), le plan de redressement du CM CELPA a été élaboré et la formation des points focaux zonaux sur la continuité des services a démarré.
- **Au Bas-Uélé**, l'évaluation de la ZS de Ganga (mai à août 2026) montre une utilisation des services comprise entre 35 et 39 % pour 60 % attendus et un taux d'occupation des lits de 30,2 à 39,4 % pour 70 % attendus ; aucune zone de triage n'est fonctionnelle et un PPL a été infecté.

2.7.2. Défis

À la Tshopo, baisse de l'utilisation des services, notamment de la maternité et des césariennes, dans l'ESS évalué ; la fermeture provisoire de l'ESS DHKis reste proposée face à la multiplication des cas confirmés et suspects.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 4 479 visites à domicile ont touché 19 349 personnes ; 276 causeries éducatives ont réuni 3 535 personnes, 8 débats communautaires ayant touché 408 personnes et 44 sensibilisations de masse ayant touché 1 089 personnes. Au total, 163 alertes communautaires, dont 67 décès, ont été notifiées ; 123 feedbacks sur 135 (91,1 %) et les 5 incidents enregistrés ont été résolus dans les 48 heures (complétude de 9 ZS sur 28).
- **Au Nord-Kivu**, 9 231 visites à domicile ont touché 28 227 personnes et 39 causeries éducatives 1 087 personnes ; 259 alertes communautaires sur 650 attendues (39,8 %) ont été notifiées et 19 feedbacks sur 25 (76,0 %) résolus dans les 48 heures. La CREC a facilité le listage de 93 contacts à Manguredjipa, de 11 à Lubero et de 9 à Oicha.
- **À la Tshopo**, 208 visites à domicile ont touché 1 165 personnes, 4 causeries éducatives 162 personnes et 12 séances de sensibilisation de masse 3 102 personnes ; les 64 alertes communautaires notifiées et les 2 feedbacks ont été traités, et 14 écoles ainsi que 55 apprenants de l'ITM La Grâce à Dieu (Lubunga) ont été sensibilisés.
- **Au Bas-Uélé**, 6 causeries éducatives et 4 sensibilisations de masse ont touché 830 personnes à Viadana, Titule et Ganga ; une émission interactive à la radio communautaire Bima (Titule) a répondu à la rumeur du 28 septembre sur la vaccination des élèves et 16 leaders ont été sensibilisés à Poko.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 12 cas confirmés (100 %) enregistrés la veille et 246 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les 6 ZS ayant notifié. Les équipes ont accompagné 34 ménages d'enfants séparés et orphelins (100 %), annoncé 98 résultats, dont 12 positifs, et réinséré 8 guéris.
- **En Ituri**, 19 des 36 derniers cas confirmés, 80 confirmés en cours de suivi sur 148 (54,1 %), 36 nouveaux suspects sur 83 (43,4 %) et 113 suspects en cours de suivi sur 138 (81,9 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 213 accompagnants et 82 PPL, suivi 13 guéris sur 19 en communauté (68,4 %) et annoncé 73 résultats, dont 19 positifs.
- **À la Tshopo**, les équipes ont apporté un soutien psychologique à 4 cas confirmés au CTE Météo, réalisé la psychoéducation de 9 suspects et de 108 personnes et annoncé 3 résultats, dont 2 positifs de la veille ; un guéri a été réinséré dans sa communauté.

- **Au Haut-Uélé**, 1 nouveau cas confirmé, 20 confirmés en cours de suivi, 8 nouveaux suspects et 5 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS à Isiro, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 58 accompagnants et 46 PPL et annoncé 15 résultats, dont 1 positif (données de Pawa non transmises).

2.9.2. Défis

- **En Ituri**, seules 13 ZS affectées sur 28 sont couvertes ; renforcer en urgence les capacités des psychologues et des agents psychosociaux pour les interventions autour des cas à Mandima.
- **Au Haut-Uélé**, difficultés de mobilité des APS à Wamba et Boma Mangbetu, insuffisance de kits nutritionnels pour les nourrissons sevrés et faible remontée des données à Pawa et Boma Mangbetu.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, suivi de la construction du CTE de Bafwasende, réception de 11 tonnes de médicaments (PHATKIN) à Bafwasende et des intrants de laboratoire (OMS), appui à la mobilité des piliers et dotation d'intrants PCI aux CUKIS.
- **Au Bas-Uélé**, réception des intrants PCI offerts par FHI 360, appui au déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana, poursuite de la réhabilitation des bureaux de la DPS (OMS) et de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, le pilier Mitigation des risques et sécurité a réalisé 6 activités de couverture sécuritaire, dont l'accompagnement à 100 % des équipes EDS pour l'enterrement de 3 cas confirmés au cimetière de Bundji (Beni) et pour 3 swabs dans la ZS de Katwa.

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 80 membres du personnel (20 femmes et 60 hommes) ont été briefés sur la PSEA et 80 intervenants de la riposte sensibilisés dans les ZS de Bunia, Rwampara, Aru et Rimba ; 831 personnes (622 femmes et 209 hommes) ont été sensibilisées dans la communauté avec l'appui de l'OMS et de Mercy Corps.
- **Au Haut-Uélé**, 492 personnes, dont 452 élèves, ont été sensibilisées sur la PSEAH et le mécanisme de signalement (495555/151) à Isiro, Wamba et Boma Mangbetu ; 8 membres du personnel ont été briefés, dont 5 ont signé le code de bonne conduite.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS sur 7 ont rapporté leurs activités PSEA (28,6 %) et les CBCM restent peu efficaces.

MESSAGES CLES

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé, Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : La totalité (**100 %**) des suspects a été investiguée dans les 24 heures suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est supérieur par rapport à la veille (**78,7 vs 73,5%**).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés. **À Mangobo (Tshopo)**, deux cas confirmés évadés du CTE restent signalés à domicile.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd